

■ SMA／FDA承認

SMN2標的薬の先へ 筋肉に効く薬が初承認

第3相188人、運動機能はプラセボ比+2.2点

FDAは9月11日、Scholar RockのISEMBYLD（アピテグロマブ、ミオスタチン阻害薬）を承認した。対象はヌシネルセンなどSMN2標的薬を使用中の2歳以上。筋肉そのものに作用する薬としては初めての承認で、神経の薬に筋肉の薬を重ねる発想になる。

根拠は第3相SAPPHIRE試験。9か国188人、2～

21歳の5q型SMAを対象にした二重盲検プラセボ対照試験で、推奨用量10mg/kgを4週ごとに約1年投与した。運動機能評価HFMSEはプラセボ比+2.2点（名目p=0.0121）、3点以上改善した割合は投与群34.2%・プラセボ群13.5%（オッズ比3.8）だった。

一方、骨折は投与群9%・プラセボ群2%と増えている。示された数値は名目p値で、多重性を調整した確定的な統計ではない。SMN2標的薬だけでは届かなかった筋量・筋力に手が伸びた一方、荷重や移乗の場面でPT・OTが把握しておきたい安全性情報でもある。



第3相SAPPHIRE試験の
主要な数字

出典 **Scholar Rock**
(プレスリリース) ↗

数字で見る

188人

SAPPHIRE試験の対象

+2.2点

HFMSEのプラセボ差

9%

骨折の発生率（投与群）

■ 脳卒中／クロスオーバーRCT

座れない歩行への対策でなく 座ったままの対策

慢性期脳卒中15人に3時間の座位を2条件で実施。何もしない座位と、10分ごとに座ったまま両足のかかと上げを10回行う座位を、同じ人で入れ替えて比較した（クロスオーバー）。

中心血圧の上昇は、かかと上げありで5.6mmHg、なしで9.6mmHg（交互作用p<0.05）。個人差は大きく、上昇幅の95%信頼区



間はどちらも0をまたぐ。歩行の休憩が使えない人向けの、負荷の低い選択肢として著者らは位置づけている。※査読前。

出典 **medRxiv** (プレプリント) ↗

■ 脳卒中／パイロットRCT

バランス訓練、最低何回で 意味があるか

亜急性期脳卒中36人を、RBTを1・3・6回組み込んだ6セッションに割り付け。実際の受講回数は平均1.0・2.9・5.7回とほぼ計画通りだった。

転倒を6か月追跡した30人で計15件。転倒を主要評価にした本試験には408～782人が必要と試算され、単一施設では非現実的。バランス反応など代替指標なら30～72人で



足りるとし、次の試験設計につなげる。※査読前で、実施可能性の検証段階。

出典 **medRxiv** (プレプリント) ↗

短 信

〈脳卒中・前臨床〉注射材料で脳の再生を助ける

マウス脳卒中モデルに損傷部注入。8週で運動機能が健常対照と同水準に。血管新生・軸索増加も確認。※動物実験段階。 出典 Cell Biomaterials／Duke大 ↗

〈呼吸リハ〉結核後肺疾患にも施設リハを

インド・オディシャ州で計画中の準実験研究。結果はまだ無い。※プロトコル段階。 出典 medRxiv ↗

〈薬剤〉乳がん治療薬、主要試験で未達

アストラゼネカのカミゼストラント、第3相SERENA-4系試験で主要評価に届かず。 出典 STAT News ↗